

ALPHI

Informe ejecutivo para accionistas

Producto comercial: ALPHI

Nombre técnico / repositorio: Ichtys Clinical Document Assistant

Organización: CINME / Innova Trials

Fecha del informe: 4 de julio de 2026

Clasificación: Confidencial - uso interno y accionistas

Contacto: sisbert@cinme.com.ar

Producción: <https://asistente-bot-five.vercel.app>

Repositorio: github.com/Santiagoisper/Asistente_bot (monorepo, carpeta ichtys/)

Índice

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Qué es ALPHI
- 3. La idea y la oportunidad
- 4. Qué construimos - visión de producto
- 5. Qué construimos - visión de ingeniería
- 6. Diferenciación frente a la competencia global
- 7. Dónde estamos parados hoy
- 8. Cómo funciona ALPHI - flujogramas
- 9. Guía de demostración paso a paso (links en vivo)
- 10. Evidencia técnica y métricas
- 11. Modelo de negocio
- 12. Roadmap y próximos hitos
- 13. Riesgos y mitigaciones
- 14. Anexos y documentación de soporte

1. Resumen ejecutivo

ALPHI es un asistente documental clínico con inteligencia artificial, diseñado para **sitios de ensayo clínico** (CRC, enfermería, investigadores, monitores). Responde preguntas operacionales sobre protocolos, Investigator Brochures y manuales de **200-400 páginas**, con **citas obligatorias** al documento fuente. Si no hay evidencia suficiente, **no responde** - no inventa.

Mensaje central para accionistas

Dimensión	Estado julio 2026
Producto MVP	[OK] Funcional en producción
Diferenciador técnico	Grounding-only + aislamiento multi-tenant + audit trail
Compliance Fase 0	[OK] Cerrada (DPA, DPIA, HIPAA, 13+ políticas)
Validación CSV (Part 11)	[EN PROGRESO] ~70 % - IQ/OQ/IT PASS; PQ piloto pendiente
Certificaciones ISO	[PENDIENTE] ISMS lite; sin auditor externo aún
Ingresos	Pre-revenue; piloto CINME en preparación
Go-live PHI real	Bloqueado hasta PQ + VSR firmado

En una frase: *Construimos el producto difícil (trial-ops regulado), no el producto fácil (chat genérico sobre PDFs). El código está; falta cerrar validación en sitio y escalar comercialmente.*

2. Qué es ALPHI

Definición

ALPHI es una **plataforma web multi-tenant B2B** que combina:

1. **Chat RAG documental** - preguntas en lenguaje natural con respuestas ancladas a documentos del ensayo y citas clickeables.
2. **Extracción estructurada del protocolo (Study Spec)** - criterios de inclusión/exclusión, visitas, endpoints, medicación permitida/prohibida.
3. **Módulo clínico de sujetos (PHI-ready)** - evoluciones cifradas, perfil del paciente, screening determinista, OCR de laboratorios con revisión humana.

Usuarios objetivo

Rol	Uso principal
CRC / Research Nurse	Elegibilidad, visitas, labs, medicación en sala
PI / Sub-I	Verificación rápida con evidencia trazable
Monitor / CRA	Validar que las respuestas tienen fuente auditable
Sponsor / Admin	Gobernanza multi-estudio, configuración, métricas

Qué NO es ALPHI

- No es un CTMS completo (Medidata, Veeva, etc.).
- No es un generador de epicrisis para consultorio (Pacientry, etc.).
- No es ChatGPT sobre PDFs sin trazabilidad.
- No está certificado FDA Part 11 ni ISO 27001 (aún).

3. La idea y la oportunidad

El problema

Los equipos de sitio pierden **tiempo crítico** buscando en documentos fragmentados durante operaciones en vivo:

- Paciente en sala -> la coordinadora no puede salir 15 minutos a buscar en el PDF.
- Monitor pide **evidencia trazable** de una decisión operacional.
- Staff nuevo en onboarding de un estudio complejo.
- Evento adverso -> verificar timeline de reporte SAE/SUSAR en minutos.

Nuestra tesis

La fuente trazable es el producto, no el chat.

Competidores optimizan velocidad de salida al mercado con términos "experimentales". ALPHI invierte en **profundidad regulada** antes de escala: tenant isolation, audit trail, validación CSV, contratos BAA/DPA con procesadores, rule engine determinista para screening.

Oportunidad de mercado

- **LATAM cardiometabólico** como beachhead (estudios T2D, obesidad, MASH).
- Buyer B2B: sponsor, CRO, red de sitios - contrato por estudio/sitio, no por usuario suelto.
- Barrera de entrada: replicar documentación + tests + contratos = **12-24 meses** para un entrante sin equipo QA/CSV.

Referencia aspiracional

Peter the Protocol Reader (Care Access / Reify Health). ALPHI apunta a superar ese benchmark en precisión de citas, trazabilidad y profundidad clínica para el mercado LATAM.

4. Qué construimos - visión de producto

Tres pilares del producto

ALPHI - Plataforma		
1. CHAT RAG Preguntas con citas exactas sobre docs	2. STUDY SPEC Protocolo -> estructura machine readable + diff	3. MÓDULO CLÍNICO Sujetos, evoluciones, screening, labs OCR (PHI cifrado)

Funcionalidades entregadas (MVP en producción)

Módulo	Capacidad	Estado
Multi-tenant	Organizaciones -> estudios -> documentos (Clerk Orgs)	[OK] Prod
Upload PDF	Hasta 50 MB; parsing por página; chunking + embeddings	[OK] Prod
Chat grounded	Respuesta + citas + confidence; sin evidencia -> abstención	[OK] Prod
Visor de citas	Navegación a página exacta del documento fuente	[OK] Prod
Study Spec	Extracción IA + aprobación humana + export + diff versiones	[OK] Prod
Screening	Rule engine determinista vs spec aprobado (pass/fail/unknown)	[OK] Prod
Sujetos clínicos	CRUD pseudonimizado, evoluciones cifradas AES-256-GCM	[OK] Prod
Labs OCR	Extract -> revisión humana -> confirm/reject	[OK] Prod
Audit trail	Log append-only de acciones (sin PHI en metadata)	[OK] Prod
Admin RAG	Config threshold/topK por organización en /settings	[OK] Prod
Cron recovery	Recuperación automática de documentos stuck	[OK] Prod
Trust / Legal	Trust center, pricing, ROI, privacy, terms	[OK] Prod

Contrato de producto (no negociable)

1. **Grounding-only** - solo responde desde documentos cargados del estudio activo.
2. **Citas obligatorias** - cada afirmación relevante lleva referencia verificable.
3. **LLM extrae, reglas deciden** - el modelo no es juez de elegibilidad final.
4. **Human-in-the-loop** - spec, OCR labs e inclusiones críticas requieren confirmación humana.
5. **Fail safe** - unknown / insufficient_evidence > falso positivo.

5. Qué construimos - visión de ingeniería

Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Frontend	Next.js 15 App Router, TypeScript, Tailwind
Auth / multi-tenant	Clerk Organizations + RBAC
Base de datos	Neon Postgres serverless + pgvector
Almacenamiento	Vercel Blob (PDFs privados)

Capa	Tecnología
IA	Anthropic Claude (chat/extracción) + OpenAI embeddings
Hosting / CI	Vercel + GitHub Actions + Turborepo/pnpm
Cifrado PHI	@ichtys/crypto - AES-256-GCM field-level

Arquitectura de paquetes (monorepo)

```
ichtys/
├── apps/web/           -> Aplicación Next.js (UI + API routes)
├── packages/
│   ├── db/            -> Schema Drizzle, migraciones Neon
│   ├── rag/           -> Retrieval, answer engine, annotator
│   ├── ingestion/     -> PDF parse, chunk, embed, spec extractor
│   ├── clinical/      -> Screening engine, lab OCR parser, PHI redact
│   ├── crypto/        -> Cifrado field-level PHI
│   ├── auth/          -> validateStudyAccess, tenant isolation
│   └── evals/         -> Suite de evaluación RAG (SM-001..012)
└── docs/compliance/  -> 13+ políticas + CSV + FMEA + PQ + VSR
```

Qué intentamos lograr programando (decisiones de diseño)

Decisión	Por qué
Aislamiento org+study antes del vector search	Un bug de leakage es catastrófico en ensayos
Pipeline de ingestion explícito (sin orquestador opaco)	Debuggeable, validable, auditable
Rule engine determinista para screening	Part 11 exige reproducibilidad; LLM no decide
Cifrado field-level en evoluciones y perfiles	HIPAA/GDPR at-rest en DB compartida
Gate unificado validate:product	7 checks en un comando - evidencia CSV repetible
29 tests OQ en CI	Cada push valida módulo clínico automáticamente
Pre-redacción antes de enviar texto a LLM	DNI, email, teléfono nunca salen al proveedor
Zero-retention en APIs de IA	BAA con Anthropic/OpenAI; no training on customer data

Qué intentamos lograr como software (experiencia)

Job to be done	Cómo lo resuelve ALPHI
Elegibilidad en screening	Chat cita § inclusión + módulo screening determinista
Pre-visita	Pregunta "¿procedimientos visita 4?" -> cita Schedule of Assessments
Medicación prohibida	Cita § Concomitant/Prohibited Medication
Labs y muestras	Cita Lab Manual + OCR labs con confirmación humana

Job to be done	Cómo lo resuelve ALPHI
Safety reporting	Cita timelines SAE/SUSAR del protocolo
Preparación monitor	Historial + citas + export spec

6. Diferenciación frente a la competencia global

Mapa competitivo

	Pacientry	ALPHI	CTMS clásico	ChatGPT / Copilot
Qué hace	Epicrisis, CIE-11, OCR médico general	RAG + citas sobre docs de ensayo + screening	Operaciones trial end-to-end	Chat genérico
Buyer	Médico individual	Sponsor / CRO / red	Enterprise pharma	Cualquiera
Regulación	ToS "experimental"	Framework CSV + compliance real	Part 11 maduro	Sin compliance clínico
Trazabilidad	Baja	Citas obligatorias + audit trail	Alta (pero rígido/caro)	Ninguna
Precio	~USD 0.59/epicrisis	B2B por estudio/sitio	Enterprise six-figure	USD 20/mes
Time-to-value	Minutos (self-serve)	Semanas (piloto + validación)	Meses (implementación)	Instantáneo (inútil en GCP)

Por qué ALPHI es diferente (foso)

1. **Grounding-only como contrato de producto**, no como marketing - verificable con eval suite SM-001..012.
2. **13+ políticas de compliance** + implementación técnica (cifrado, audit, leakage tests).
3. **BAAs/DPA firmados** con Neon, Vercel, Clerk, Anthropic, OpenAI, Upstash **antes** de PHI real.
4. **Validación CSV en curso** con trazabilidad URS -> FRS -> tests (RTM v1.0).
5. **Barrera regulatoria** - un competidor self-serve tarda años en replicar sin equipo QA/CSV dedicado.

Qué NO copiamos (a propósito)

- Disclaimer "experimental / declinamos responsabilidad clínica" (Pacientry).
- Diagnósticos diferenciales generativos sin evidencia.
- Claims inflados de certificación Part 11 o ISO.

7. Dónde estamos parados hoy

Posición global del programa

Etapa 0	Producto MVP		CERRADA
Etapa 1	Legal pre-PHI		CERRADA (04-jul-2026)
Etapa 2	Validación CSV		EN CURSO (~70 %)
Etapa 3	Go-live PHI piloto		PENDIENTE
Etapa 4	Escala + ISO formal		ROADMAP 2026-2027

Por marco regulatorio

Marco	¿Certificado?	Madurez estimada	Próximo hito
FDA 21 CFR Part 11	No	~70 % CSV	PQ piloto + VSR
EMA Annex 11	No	~65 %	Igual que Part 11
ICH E6 GCP	N/A	~60 % alineación producto	Capacitación sitio
GDPR	No (no existe sello)	~80 % docs	Asignar DPO
HIPAA	No	~75 % docs/contratos	Security Officer
ISO 27001	No	~35 %	SOC 2 readiness Q4 2026
ISO 27701	No	~25 %	Extensión 2027
ISO 42001	No	~30 % lite	Post-27001

Evidencia verificable (julio 2026)

Gate	Resultado
validate:product	7/7 OK
OQ tests	29/29 PASS (CI)
IT PHI	4/4 PASS
IQ prod	11/11 OK
Eval RAG SM-001..012	12/12 PASS
Leakage cross-tenant	0 fallos
Smoke PHI prod	create + delete OK

Detalle completo: docs/audits/ALPHI_FULL_AUDIT_2026-07-04.md

Posición regulatoria: docs/compliance/REGULATORY-POSITION-SHAREHOLDERS.md

8. Cómo funciona ALPHI - flujogramas

8.1 Flujo general de la plataforma

Diagrama de flujo

```
flowchart TB
    subgraph usuarios [Usuarios del sitio]
        CRC[CRC / Enfermería]
        PI[Investigador]
        MON[Monitor]
    end

    subgraph alphi [ALPHI - asistente-bot-five.vercel.app]
        AUTH[Clerk Auth + Org/Study RBAC]
        subgraph modulos [Módulos]
            DOCS[Documentos PDF]
            CHAT[Chat RAG + Citas]
            SPEC[Study Spec]
            SUBJ[Sujetos + Screening + Labs]
        end
        AUDIT[Audit Log]
    end

    subgraph backend [Infraestructura]
        NEON[(Neon Postgres + pgvector)]
        BLOB[Vercel Blob]
        LLM[Anthropic + OpenAI]
    end

    CRC --> AUTH
    PI --> AUTH
    MON --> AUTH
    AUTH --> modulos
    modulos --> NEON
    DOCS --> BLOB
    CHAT --> LLM
    SPEC --> LLM
    modulos --> AUDIT
```

8.2 Pipeline de ingesta de documentos

Diagrama de flujo

```
flowchart LR
    A[Usuario sube PDF] --> B[POST /api/documents/upload]
    B --> C[Vercel Blob storage]
    C --> D[Parse por página]
    D --> E[Chunking section-aware]
    E --> F[Embeddings OpenAI]
    F --> G[(chunks + pgvector)]
    G --> H[status: ready]
    H --> I[Disponible para Chat RAG]
```

8.3 Pipeline RAG (chat con citas)

Diagrama de flujo

```
flowchart TD
    Q[Pregunta del usuario] --> A{Auth + org + study OK?}
    A -->|No| E401[401 / 403]
    A -->|Sí| B[Embed pregunta]
    B --> C[Vector search FILTRADO por org_id + study_id]
    C --> D{Similarity >= threshold?}
    D -->|No| INSUF[insufficient_evidence]
    D -->|Sí| E[LLM con contexto grounded]
    E --> F[Respuesta + citas + confidence]
    F --> G[Persistir message + citations]
    G --> H[Stream al cliente]
    F --> I[Audit log]
```

8.4 Flujo clínico - screening y labs

Diagrama de flujo

```
flowchart TD
    EVO[Evolución clínica cifrada] --> NLP[NLP extract Haiku]
    NLP --> PROF[Perfil paciente cifrado]
    PROF --> RULE[Rule engine determinista]
    SPEC[Study Spec aprobado] --> RULE
    RULE --> SCR[Screening pass/fail/unknown]

    LABTXT[Texto lab pegado] --> OCR[Lab OCR parser]
    OCR --> REV{Revisión humana}
    REV -->|Confirm| PROF
    REV -->|Reject| PEND[Pending cleared]
```

8.5 Flujo de validación CSV (programa compliance)

Diagrama de flujo

```
flowchart LR
    F0[Fase 0 Legal] --> IQ[IQ 11/11]
    IQ --> OQ[OQ 29 tests]
    OQ --> IT[IT 4 tests]
    IT --> PQ[PQ piloto CINME]
    PQ --> VSR[VSR firmado]
    VSR --> GO[Go-live PHI real]
```

9. Guía de demostración paso a paso (links en vivo)

URL base: <https://asistente-bot-five.vercel.app>

Estudio demo: MOCK-METABOLIC-T2D-v1

UUID estudio: 508fa9c9-dbb9-49aa-abd5-7f7fe968bbc6

Organización demo: INNOVA TRIALS

Todos los documentos del demo son ficticios, sin PHI real. Ideal para mostrar a accionistas sin riesgo de privacidad.

Fase A - Superficie pública (sin login) · ~5 minutos

Mostrar que ALPHI tiene **presencia comercial y compliance visible** - algo que muchos competidores técnicos no tienen.

Paso	Qué mostrar	URL
A1	Landing - propuesta de valor	https://asistente-bot-five.vercel.app
A2	Trust Center - procesadores, cifrado, políticas	https://asistente-bot-five.vercel.app/trust
A3	Pricing - modelo por estudio/sitio	https://asistente-bot-five.vercel.app/pricing
A4	Calculadora ROI - ahorro operacional estimado	https://asistente-bot-five.vercel.app/roi
A5	Privacidad	https://asistente-bot-five.vercel.app/privacy
A6	Términos de uso	https://asistente-bot-five.vercel.app/terms

Narrativa sugerida: "No somos un wrapper de ChatGPT. Tenemos trust center, pricing y marco legal antes de escala."

Fase B - Acceso y dashboard · ~2 minutos

Paso	Qué mostrar	URL
B1	Login (Clerk)	https://asistente-bot-five.vercel.app/sign-in
B2	Dashboard post-login	https://asistente-bot-five.vercel.app/dashboard
B3	Lista de estudios	https://asistente-bot-five.vercel.app/studies

Credenciales: usar cuenta demo INNOVA TRIALS (proporcionar al presentador antes de la reunión).

Fase C - Estudio mock T2D - corazón del producto · ~15 minutos

URL base del estudio:

https://asistente-bot-five.vercel.app/studies/508fa9c9-dbb9-49aa-abd5-7f7fe968bbc6

Paso	Módulo	URL	Qué demostrar
C1	Documentos	/studies/508fa9c9-dbb9-49aa-abd5-7f7fe968bbc6/documents	5 PDFs mock cargados (Protocolo, IB, Lab, Pharmacy, Procedures); status ready
C2	Chat RAG	/studies/508fa9c9-dbb9-49aa-abd5-7f7fe968bbc6/chat	Preguntas con citas - ver script abajo
C3	Study Spec	/studies/508fa9c9-dbb9-49aa-abd5-7f7fe968bbc6/spec	Criterios extraídos, visitas, endpoints; spec aprobado
C4	Historial	/studies/508fa9c9-dbb9-49aa-abd5-7f7fe968bbc6/history	Conversaciones previas auditables
C5	Sujetos	/studies/508fa9c9-dbb9-49aa-abd5-7f7fe968bbc6/subjects	Lista de sujetos pseudonimizados
C6	Detalle sujeto	/studies/508fa9c9-dbb9-49aa-abd5-7f7fe968bbc6/subjects/{subjectId}	Evolución, perfil, screening, labs OCR
C7	Biblioteca	https://asistente-bot-five.vercel.app/library	Vista transversal de documentos
C8	Settings RAG	https://asistente-bot-five.vercel.app/settings	Threshold y topK configurables por org
C9	Import bulk	https://asistente-bot-five.vercel.app/studies/import	Importación masiva de estudios (admin)

Fase D - Script de 6 preguntas para el chat (copy-paste)

Abrir **C2 - Chat** y pegar cada pregunta. Mostrar siempre el **botón de cita** y la página fuente.

#	Pregunta	Resultado esperado
1	¿Un paciente con HbA1c de 9% cumple criterio de inclusión?	Cita §3.1 Inclusion; rango 7-10%
2	¿Está excluido un paciente con antecedente de pancreatitis?	Cita §3.2 Exclusion; sí excluido
3	¿Qué procedimientos corresponden en la visita 4?	Cita §3.3 Schedule of Assessments

#	Pregunta	Resultado esperado
4	¿Cuál es la ventana permitida para la visita de seguimiento?	Cita §3.4 Visit Windows; V6 ±7 días
5	¿Está permitida metformina durante el estudio?	Cita §3.5 Concomitant Medication
6	¿Qué medicamentos antidiabéticos están prohibidos?	Cita §3.6 Prohibited Medication

Pregunta adversarial (grounding-only):

#	Pregunta	Resultado esperado
7	¿Cuál es la dosis recomendada de warfarina para este estudio?	insufficient_evidence - no inventar

Fase E - Módulo clínico (opcional, si hay sujeto demo) · ~5 minutos

En detalle de sujeto (/subjects/{id}):

- 1. **Evolución** - guardar texto con HbA1c 8.2%; mostrar que perfil se actualiza.
- 2. **Screening** - assessments pass/fail/unknown coherentes con spec.
- 3. **Labs OCR** - pegar texto de lab -> extract -> confirmar o rechazar.

Narrativa: "El LLM extrae datos; las reglas deterministas deciden elegibilidad. Humano confirma labs."

Fase F - Cierre con compliance · ~3 minutos

Paso	Qué decir	Referencia
F1	"Fase 0 legal cerrada; BAAs firmados"	Trust Center + DPA tracker interno
F2	"29 tests OQ automatizados en cada deploy"	CI GitHub
F3	"Próximo paso: PQ con 5 usuarios CINME"	docs/compliance/PQ.md
F4	"No decimos certificado Part 11 - decimos validación en progreso"	Honestidad = confianza inversor

Checklist pre-demo (5 minutos antes)

- [] Login funciona en org INNOVA TRIALS
- [] Estudio MOCK-METABOLIC visible en /studies
- [] Chat responde en < 5 segundos
- [] No hay datos reales de pacientes en pantalla
- [] Plan B: video grabado si falla conexión

10. Evidencia técnica y métricas

Gates automatizados

Métrica	Target	Estado actual
validate:product	7/7 OK	[OK] PASS
OQ tests	29/29	[OK] PASS
IT PHI	4/4	[OK] PASS
IQ prod	11/11	[OK] PASS
Eval RAG SM-001..012	12/12	[OK] PASS
Leakage cross-study/org	0%	[OK] PASS (bloqueante)
Citation correctness	> 90%	[OK] En eval interna
Latencia P90 chat	< 4 s	[OK] Target operacional

Documentación de compliance (13+ políticas)

Ubicación: ichtys/docs/compliance/

Documento	Propósito
DATA-CLASSIFICATION	Clasificación D1-D7
PHI-HANDLING-POLICY	Manejo ALCOA+
PSEUDONYMIZATION-POLICY	Pseudónimos sujetos
ACCESS-CONTROL-POLICY	RBAC + segregación
DATA-RETENTION-POLICY	Retención GCP/GDPR
BREACH-NOTIFICATION-PROCEDURE	72h GDPR / 60d HIPAA
BACKUP-AND-DR	Continuidad Neon PITR
AI-GOVERNANCE	ISO 42001 lite
ISMS-OVERVIEW	ISO 27001 lite
CSV-VALIDATION-PLAN	GAMP 5 / Part 11
DPIA	GDPR Art. 35
HIPAA-RISK-ASSESSMENT	Security Rule
DPA-BAA-TRACKER	Contratos procesadores

Documento	Propósito
URS / FRS / RTM v1.0	Trazabilidad requisitos
FMEA / PQ / VSR	Validación formal

11. Modelo de negocio

Unidad de valor

- **Por estudio activo o por sitio/red** - no por usuario individual.
- Buyer: sponsor, CRO, red de centros de investigación.

Etapas comerciales

Etapas	Oferta	Estado
Demo	Estudio mock T2D gratuito (trust + chat)	[OK] Disponible
Piloto	1 sitio, N estudios, soporte CSV	[EN PROGRESO] CINME en preparación
Enterprise	Multi-sitio, DPA/BAA, SLA, validación completa	[PENDIENTE] Post-PQ

Pricing público

Ver: <https://asistente-bot-five.vercel.app/pricing>

Calculadora ROI: <https://asistente-bot-five.vercel.app/roi>

Estado: Pre-revenue. Pricing indicativo publicado; contratos enterprise por negociación.

12. Roadmap y próximos hitos

Hito	Timeline estimado	Prerequisito
PQ piloto CINME (5 usuarios)	Q3 2026	Usuarios disponibles
VSR firmado	Post-PQ	Quality + Clinical + Security
Go-live PHI real (1 sitio)	Q3-Q4 2026	VSR
SOC 2 Type I readiness	Q4 2026	Roles ISMS asignados

Hito	Timeline estimado	Prerequisito
ISO 27001 gap assessment	H1 2027	SOC 2
Multi-sitio / billing	2027	Go-live piloto exitoso

Uso de capital (orientativo)

- 1. Cerrar validación CSV + PQ + roles compliance
- 2. Superficie GTM (demo, trust, primer piloto pagado)
- 3. OCR PDF escaneado (Reducto/Azure DI) para protocolos reales
- 4. Primer contrato sponsor LATAM cardiometabólico

13. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Retraso PQ por usuarios piloto	Alto	Protocolo listo; agendar ventana CINME
Due diligence exige ISO certificado	Medio	Roadmap SOC2/ISO; ISMS lite hoy
Competidor "AI for trials" sin CSV	Medio	Foso = profundidad regulada
Breach PHI	Crítico	Sin PHI real hasta VSR; cifrado + leakage tests
Trust page desactualizado vs DPA firmados	Bajo	Actualizar copy en próximo sprint

14. Anexos y documentación de soporte

Documentos clave en el repositorio

Documento	Ruta
Este informe	docs/pitch/ALPHI-SHAREHOLDER-REPORT-2026.md
Posición regulatoria	docs/compliance/REGULATORY-POSITION-SHAREHOLDERS.md
Auditoría jul 2026	docs/audits/ALPHI_FULL_AUDIT_2026-07-04.md
Roadmap programa	docs/ROADMAP.md
PRD producto	docs/PRD.md
Arquitectura técnica	docs/ARCHITECTURE.md

Documento	Ruta
Script demo inversores	docs/evals/demo-script.md
Pitch deck (slides)	docs/pitch/deck.md
Compliance one-pager	docs/pitch/compliance-one-pager.md
Plan CSV	docs/compliance/CSV-VALIDATION-PLAN.md
PQ protocolo	docs/compliance/PQ.md
VSR borrador	docs/compliance/VSR.md

Links externos

Recurso	URL
Producción	https://asistente-bot-five.vercel.app
Trust Center	https://asistente-bot-five.vercel.app/trust
GitHub Actions CI	https://github.com/Santiagoisper/Asistente_bot/actions
Contacto	sisbert@cinme.com.ar

Declaración de exactitud

Este informe refleja el estado del producto y del programa de compliance al **4 de julio de 2026**, basado en evidencia del repositorio, auditoría automatizada y documentación interna. ALPHI **no está certificado** bajo FDA Part 11, EMA Annex 11 ni ISO 27001/27701/42001. Las afirmaciones de cumplimiento se refieren a **alineación documental y controles técnicos verificables**, no a certificación formal.

Aprobación

Rol	Nombre	Fecha	Firma
CEO / Fundador	Santiago Isbert		
Sponsor / CINME			
Directorio / Accionistas			

ALPHI / IchtyS - Innova Trials · Julio 2026